

INFORME MÉDICO INTEGRADO

Centro de Mecánica Vascular y Cardiometabolismo

Síndrome cardiovascular-renal-metabólico (CKM) y cardio-reno-hepato-metabólico (CRHM)

Código del paciente	CKM-DEMO	Fecha	19/06/2026 03:57
Edad / sexo	58.0 años / Hombre	Profesional	Dr. Olano Ricardo Daniel - Cardiólogo Hipertensólogo

Conclusión operativa: Etapa 2: factores metabólicos, ERC o ambos. CRHM II: factores metabólicos, renales o hepáticos. Semáforo clínico: **Naranja**. El objetivo es priorizar los dominios que impulsan la progresión y seleccionar terapias con beneficio transversal cardiovascular, renal, metabólico y hepático.

1. Resultado integrado

Etapas CKM	Etapa 2: factores metabólicos, ERC o ambos
Etapas CRHM	CRHM II: factores metabólicos, renales o hepáticos
Semáforo	Naranja
Riñón	G2-A2 - KDIGO Moderado-alto
Hígado	FIB-4 1.27 (Bajo)
PREVENT-CVD ingresado	10 años 12.0% - 30 años 35.0%
PREVENT-ASCVD/HF	ASCVD 10 años 5.0% - HF 10 años 4.0%
Objetivos lipídicos	Riesgo Alto; LDL <70 mg/dL; no-HDL <100 mg/dL; ApoB <80 mg/dL

2. Items clínicos de interés

Dominio	Dato principal	Interpretación
Adiposidad	IMC 31.1 kg/m2; cintura 108 cm	Obesidad clase I; cintura aumentada
Metabólico	Síndrome metabólico 5/5; HbA1c 6.1%	Prediabetes
Presión arterial	PAS/PAD 138/86 mmHg	HTA o PA elevada
Renal	eGFR 68 ml/min/1,73m2; UACR 45 mg/g	G2-A2 - KDIGO Moderado-alto
Hepático	MASLD sí; FIB-4 1.27	Bajo. Seguimiento rutinario y control de factores metabólicos.
Lípidos	LDL 126 mg/dL; no-HDL 167.0; ApoB 110.0	Riesgo Alto; objetivos: LDL <70, no-HDL <100, ApoB <80 mg/dL
Cardiovascular	PREVENT-CVD 10 años 12.0%; ASCVD 5.0%	Sin ECV clínica/subclínica informada

3. Mapa didáctico de carga por dominios

Carga por dominios CKM/CRHM

Adiposidad		2/3
Metabólico		2/3
Renal		2/3
Hepático		1/3
Cardiovascular		1/3

Escala: 0 = sin carga evidente; 1 = leve; 2 = moderada; 3 = alta. El dominio con mayor carga debe orientar la prioridad del seguimiento y de la intervención.

4. Propuesta terapéutica integrada

Las recomendaciones son operativas y requieren confirmación de indicación, dosis, contraindicaciones, interacciones, función renal, potasio, cobertura y preferencias del paciente.

Prioridad	Dominio	Recomendación	Seguimiento
Alta	Modelo de atención	Manejo integrado CKM/CRHM con coordinación clínica: cardiología, nefrología, endocrinología/metabolismo, nutrición y hepatología si corresponde.	Revaluar etapa CKM/CRHM cada 3-6 meses si hay tratamiento activo; anual si bajo riesgo estable.
Alta	Estilo de vida	Plan cardiometabólico: patrón mediterráneo/DASH, reducción de ultraprocesados, actividad aeróbica + fuerza, sueño regular, abandono de tabaco y objetivo de peso individualizado.	Control de peso, cintura, PA domiciliaria y adherencia cada 4-12 semanas al inicio.
Alta	Adiposidad/obesidad	Considerar farmacoterapia antiobesidad si no hay contraindicaciones; en perfil CKM/CRHM favorece evaluar terapias basadas en GLP-1 o dual GIP/GLP-1. Considerar cirugía metabólica/bariátrica si IMC muy elevado o comorbilidades relevantes.	Registrar % de pérdida de peso a 3-6 meses, tolerancia gastrointestinal, masa muscular y riesgo nutricional.
Alta	Hipertensión arterial	Confirmar patrón con MDPA/MAPA si hay duda; intensificar control de PA, sodio, peso y fármacos según fenotipo clínico. En albuminuria/ERC priorizar bloqueo SRAA si tolerado.	PA domiciliaria semanal al inicio; creatinina y potasio 1-4 semanas tras iniciar/aumentar IECA/ARA II/MRA.
Media	Prediabetes/adiposidad disfuncional	Programa intensivo de pérdida de peso, actividad física y control de cintura; considerar OGTT si discordancia entre glucosa y HbA1c.	Glucemia/HbA1c cada 6-12 meses.
Media	Riñón/ERC	Cuantificar eGFR y UACR seriados. Si hay albuminuria, priorizar IECA/ARA II si tolerado. Evaluar SGLT2i si cumple criterios clínicos y eGFR permite uso.	eGFR, UACR y potasio cada 3-6 meses; antes si cambios de SRAA/SGLT2i/nsMRA.
Media	Hígado/MASLD	FIB-4: 1.27 (Bajo). Seguimiento rutinario y control de factores metabólicos. Manejo base: pérdida de peso, control de DM2/TG/PA, evitar alcohol nocivo y revisar fármacos hepatotóxicos.	Repetir FIB-4 anual si bajo riesgo; elastografía/ELF si intermedio; hepatología si alto o cirrosis.
Alta	Lípidos / objetivos LDL-no-HDL-ApoB	Alta prioridad: diabetes/ERC elevan riesgo; indicar tratamiento lipídico según guías locales. Perfil lipídico: riesgo Alto; objetivos orientativos: LDL-C <70 mg/dL, no-HDL-C <100 mg/dL, ApoB <80 mg/dL. Estatina moderada-alta intensidad; agregar ezetimibe si no alcanza objetivo. PREVENT-ASCVD 10 años 5-<10%: tratamiento hipolipemiente recomendado.	Control de LDL/no-HDL/ApoB a 4-12 semanas tras cambios y luego cada 3-12 meses.
Media	Apnea obstructiva del sueño	Aplicar STOP-Bang y solicitar estudio de sueño si riesgo alto, especialmente si HTA resistente, obesidad, FA o IC.	Revisar síntomas, adherencia a CPAP si indicada y respuesta de PA/FC.

5. Plan de control sugerido

Momento	Acción
4-12 semanas	PA, peso, cintura, adherencia, tolerancia y eventos adversos; revisar automonitoreo.
3-6 meses	HbA1c/glucemia, lípidos, eGFR, UACR, potasio si usa SRAA/MRA, ajuste terapéutico por objetivos.
6-12 meses	Recalcular etapa CKM/CRHM, revisar PREVENT si corresponde, reevaluar MASLD/FIB-4 y necesidad de elastografía.
Derivación	Nefrología si ERC progresiva/alto riesgo; hepatología si FIB-4 alto, elastografía alterada o sospecha de cirrosis; cardiología si ECV clínica, pre-IC/IC o alto riesgo.

6. Módulo farmacológico y alertas

Clase	Dosis orientativa	Alertas eGFR/K+	Precauciones / seguimiento
IECA/ARA II (SRAA)	Ej.: enalapril 2,5-5 mg c/12-24 h; losartán 25-50 mg/día, titular.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	Embarazo, angioedema por IECA, estenosis bilateral de arteria renal, hiperpotasemia significativa. Control de creatinina/eGFR y K+ a 1-4 semanas tras inicio/aumento; evitar combinación IECA+ARA II.
SGLT2i	Empagliflozina 10 mg/día o dapagliflozina 10 mg/día.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	Cetoacidosis, infecciones genitales recurrentes severas, deshidratación/hipotensión; pausar en ayuno/cirugía/enfermedad aguda. Revisar volemia, diuréticos, infecciones genitales y descenso inicial esperado de eGFR.

Clase	Dosis orientativa	Alertas eGFR/K+	Precauciones / seguimiento
GLP-1 RA / GIP-GLP-1	Semaglutida: titulación semanal; tirzepatida: 2,5 mg semanal inicial y titular.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	Embarazo/lactancia, antecedente de carcinoma medular tiroideo/MEN2; precaución pancreatitis/gastroparesia. Control de tolerancia GI, hidratación, masa muscular, interacciones por vaciamiento gástrico.
Finerenona (nsMRA)	10-20 mg/día según eGFR y K+.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	K+ elevado, eGFR <25, insuficiencia suprarrenal, uso de inhibidores potentes CYP3A4. K+ y eGFR al inicio, 4 semanas y luego periódico; revisar azoles, claritromicina, verapamilo/diltiazem.
MRA esteroideo	Espironolactona 12,5-25 mg/día o eplerenona 25 mg/día, titular.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	K+ elevado, eGFR bajo, ginecomastia/efectos endocrinos con espironolactona. Control K+/eGFR 3-7 días, 4 semanas y luego periódico si alto riesgo.
Metformina	500 mg con comida, titular a 1500-2000 mg/día si tolera.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	eGFR <30, acidosis, hipoxia/sepsis; pausar en contraste y enfermedad aguda relevante. B12 periódica, función renal, síntomas GI.
Estatina +/- ezetimibe	Atorvastatina 20-80 mg/día o rosuvastatina 5-40 mg/día; ezetimibe 10 mg/día.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	Hepatopatía activa descompensada, embarazo; precaución miopatía e interacciones. Perfil lipídico 4-12 semanas; ALT/CK si clínica; revisar macrólidos, azoles, ciclosporina.
PCSK9i / inclisirán / ácido bempedoico	Evolocumab/alirocumab SC cada 2-4 semanas; inclisirán SC día 0, 3 meses y luego c/6 meses; bempedoico 180 mg/día.	Sin alerta renal/potasio mayor con los datos ingresados.	Revisar cobertura, embarazo; bempedoico: gota/ácido úrico y tendón. LDL a 4-12 semanas; adherencia y acceso.

Firma digital / sello profesional
Dr. Olano Ricardo Daniel - Cardiólogo Hipertensólogo
Centro de Mecánica Vascular y Cardiometabolismo

Este informe es una herramienta de apoyo clínico y educación médica. No reemplaza el juicio clínico, la confirmación diagnóstica ni la prescripción individualizada. Antes de indicar tratamiento confirmar dosis, contraindicaciones, interacciones, función renal, potasio, estado hepático, embarazo/lactancia cuando aplique, acceso/coertura y preferencias del paciente.